PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Lesão muscular no esporte

O que falha, como avaliar e como classificar

Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

UMA PALAVRA QUE ESCONDE TUDO

“Teve uma lesão muscular.”

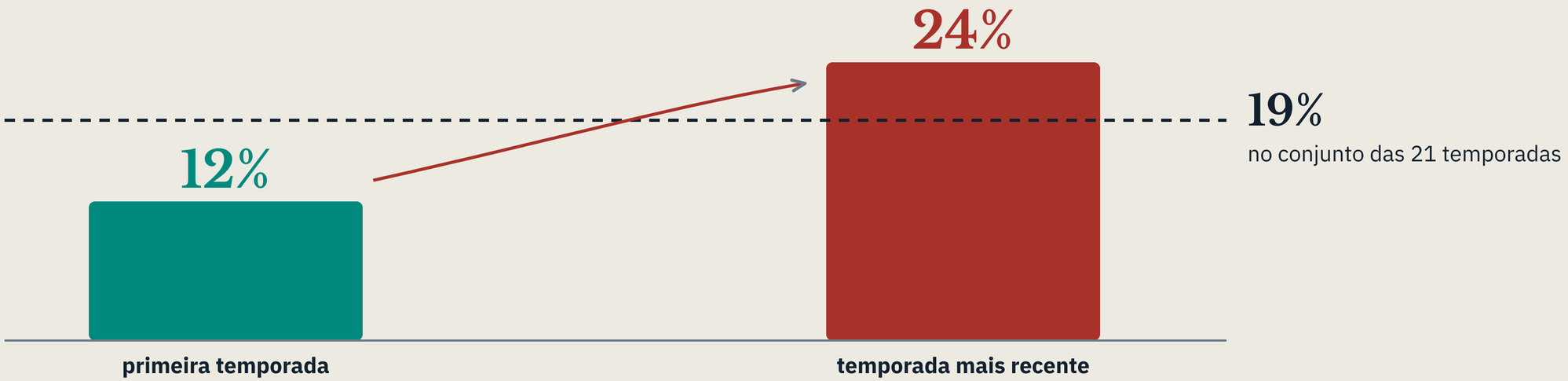
sobrecarga que passa em poucos dias — **ruptura que envolve o tendão e leva meses**



tudo isso cabe na mesma frase

1. o que falha
2. a avaliação
3. a imagem
4. a classificação

Posterior de coxa no futebol de elite europeu



Quase uma em cada quatro lesões, num único grupo muscular, e crescendo.

Estudo de lesões dos clubes de elite da UEFA, Br J Sports Med 2023

Dois cenários de alongamento sob tensão

Corrida em alta velocidade



- fim do balanço da perna
- isquiotibiais freiam enquanto alongam
- cabeça longa do bíceps femoral
- a mais comum no jogador e no velocista

Alongamento extremo



- chute alto, abertura, carrinho, dança
- dor mais alta, perto do quadril
- pouca perda de função no primeiro dia
- recuperação mais longa

> A segunda engana: o susto é pequeno e o prazo é grande.

Dois estudos suecos, Am J Sports Med 2007

ONDE FALHA

O tendão também corre por dentro do músculo



Quando a lesão pega o tendão interno, demora mais para liberar sprint e repete mais.

Esquema, sem escala

A história vale mais do que parece

1

O que fazia

sprint, chute, abertura, desaceleração

2

O que sentiu

estalo, pontada, ou algo que apertou aos poucos

3

Continuou?

conseguiu seguir no treino, conseguiu andar

4

Já teve antes?

no mesmo lugar, e quando

a que mais se esquece

> A última pergunta é a que mais se esquece, e é a que mais muda o plano.

O que a maca mostra e o que muda a urgência

O exame

- onde dói e em que extensão
- amplitude perdida, lado a lado
- dor ao contrair, com e sem resistência
- falha palpável

Sinais que mudam a urgência

- **não consegue andar**
- **hematoma extenso em poucas horas**
- **dor muito alta, perto do osso da bacia**
- **no adolescente: pensar em arrancamento**

> Com história e exame, quem examina já separa o leve do sério e decide se precisa de imagem.

PASSO TRÊS · IMAGEM COM PERGUNTA

Quando a ressonância muda a decisão

o laudo muda a decisão?

sim: ajuda

- ✓ dúvida de gravidade ou de arrancamento
- ✓ prazo apertado e tendão interno em jogo
- ✓ evolução que não bate com o esperado

não: não ajuda

- ✗ pedida por reflexo, no dia seguinte
- ✗ desconforto leve, já melhorando
- ✗ plano que não muda com o laudo

> Em 180 atletas, a ressonância não acrescentou valor à história e ao exame para prever o retorno.

Coorte norueguesa, Br J Sports Med 2015

Três advertências que evitam erro caro

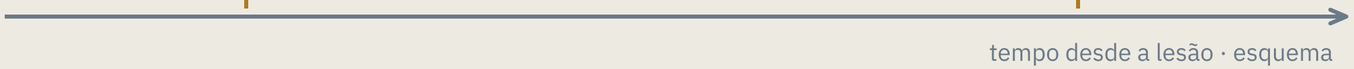
Cedo demais

pode subestimar a lesão

o momento importa

Tarde demais

pode mostrar cicatriz antiga e confundir



Achado sem sintoma

o edema persiste em quem já voltou a treinar bem

A imagem, sozinha, não decide quando a pessoa volta.

PASSO QUATRO · CLASSIFICAR

Consenso de Munique, 2013

Funcional

sem ruptura de fibra

sem ruptura

sobrecarga por fadiga, dor muscular tardia

→ **costuma resolver rápido**

neuromuscular

inclui a dor que vem da coluna lombar

→ **tratada como ruptura por engano**

Estrutural

com ruptura de fibra

parcial

ruptura de fibra, pequena a moderada

→ **prazo pelo exame**

completa

ruptura total e arrancamento do tendão

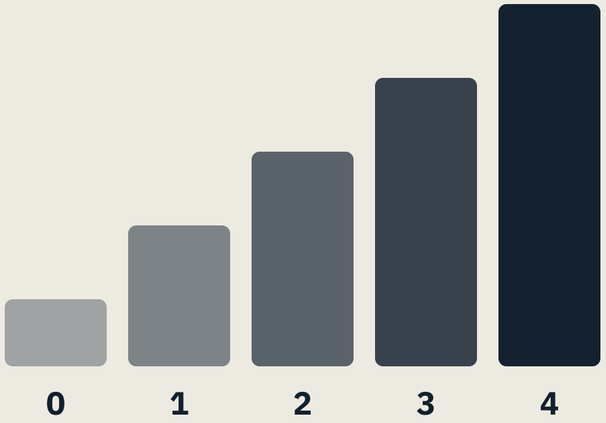
→ **avaliação cirúrgica**

Br J Sports Med 2013

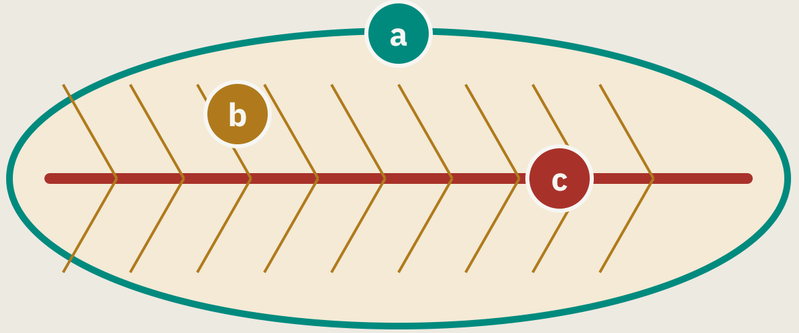
CLASSIFICAÇÃO BRITÂNICA, 2014

Grau de 0 a 4 pelo tamanho, letra pelo lugar

o grau: tamanho



a letra: lugar



Letra a
periferia, perto da fáscia

Letra b
no músculo ou na junção com o tendão

Letra c
estende-se para dentro do tendão

No atletismo de elite, a letra c demorou mais para voltar ao treino completo e repetiu mais.

Br J Sports Med 2014 e 2016

Ritmo por critério, não por calendário

Proteger sem imobilizar

repouso relativo, dor controlada, movimento no que não dói

Carga cedo, progressão por critério

periférica: avança rápido

tendão interno: devagar

O gesto volta antes da alta

sprint na reabilitação, não no jogo

primeiro dia → volta ao esporte

> Quando o calendário pula a última etapa, o jogo faz a exposição, em velocidade máxima e com adversário.

QUATRO ERROS

A dor some antes de a capacidade voltar

- Não chame tudo de estiramento
- Lembre da dor que vem da coluna
- Não imobilize no começo, não apresse o fim

Médico

Diagnostica, classifica, pede e interpreta imagem.

Fisioterapia e preparação

Progridem o tecido, a força e o gesto.

Coordenação

Comunica prazo com o médico, nunca de improviso.

Próxima aula: o prazo, e por que a previsão erra tanto.